

COMPTE-RENDU DE CONSULTATION MÉDICALE

Document fictif généré à titre d'exemple / modèle — ne constitue pas un document médical réel

Nom du patient :	DUPONT Amine (fictif)	Date de naissance :	12/04/1998
N° de dossier :	PAT-2026-00427 (fictif)	Sexe :	Masculin
Médecin :	Dr. Sami Ben Ali (fictif)	Date de consultation :	15/07/2026
Établissement :	Clinique Ibn Khaldoun (fictif)	Spécialité :	Gastro-entérologie

Motif de consultation

Le patient consulte pour des douleurs abdominales récurrentes, des ballonnements et une fatigue chronique évoluant depuis environ 8 mois, associés à une perte de poids involontaire de 4 kg et des épisodes de diarrhée intermittente.

Antécédents

- Antécédents familiaux : sœur suivie pour une maladie cœliaque diagnostiquée à l'âge de 20 ans.
- Antécédents personnels : anémie ferriprive légère détectée il y a 1 an.
- Pas de tabagisme, pas de consommation d'alcool régulière.

Examen clinique

État général conservé. Sensibilité abdominale diffuse à la palpation, sans défense ni contracture. Pâleur cutanéomuqueuse modérée. IMC : 19,8 kg/m² (léger amaigrissement par rapport au poids habituel).

Examens complémentaires

Examen	Résultat	Valeurs de référence
Anticorps anti-transglutaminase IgA (tTG-IgA)	62 U/mL (positif élevé)	< 10 U/mL
Anticorps anti-endomysium (EMA)	Positif	Négatif
IgA totales sériques	Normales	Normales (exclut déficit en IgA)
NFS	Hb 10,8 g/dL (anémie légère)	13-17 g/dL
Ferritine	8 ng/mL (basse)	20-250 ng/mL
Biopsie duodénale (endoscopie)	Atrophie villositaire partielle, classée Marsh IIIa	Muqueuse normale

Diagnostic retenu

Maladie cœliaque confirmée par la sérologie positive (tTG-IgA, EMA) et la biopsie duodénale objectivant une atrophie villositaire (Marsh IIIa), dans un contexte clinique compatible (troubles digestifs chroniques, anémie ferriprive, antécédent familial).

Prise en charge et recommandations

- Instauration d'un régime strict sans gluten (exclusion du blé, de l'orge, du seigle et de leurs dérivés), à vie.
- Orientation vers une diététicienne spécialisée pour l'éducation nutritionnelle.
- Supplémentation en fer et acide folique pendant 3 mois, avec contrôle de la NFS et de la ferritine.
- Dosage de la vitamine D et calcium, et ostéodensitométrie à discuter si carence prolongée.
- Vaccination antipneumococcique à envisager (asplénie fonctionnelle possible dans les formes sévères — à évaluer).
- Contrôle sérologique (tTG-IgA) à 6 mois pour évaluer la réponse au régime.

Suivi proposé

Consultation de contrôle dans 3 mois avec bilan biologique (NFS, ferritine, tTG-IgA). Nouvelle endoscopie avec biopsie envisagée à 12 mois pour confirmer la normalisation muqueuse sous régime sans gluten.

■ Ce document est un exemple fictif généré à des fins de démonstration ou de modèle (patient, médecin et données inventés). Il ne doit pas être utilisé comme document médical réel ni comme base de décision clinique.

Document généré le 15/07/2026